



Osteoartrite

Definição

Nos EUA há mais de 50 milhões de pessoas com essa doença.

Caracteriza-se como uma insuficiência qualitativa e quantitativa da cartilagem articular associada a alterações típicas do osso subcondral levando a formação de osteófitos.

85% apresentam evidências radiográficas de OA por volta dos 65 anos. A distribuição da doença é semelhante até os 40 anos, mas a medida que envelhece é muito mais comum na mulher.

Nos mais idosos do sexo masculino predomina OA de quadril e em mulheres mais em IFD e IFP e primeiro metacarpo.

Etiologia

- **Fatores genéticos:** por exemplo osteoartrite de mãos;
A predisposição genética envolve principalmente as formas nodais de OA de mãos e algumas formas de generalizada (acometimento de mais de 2 sítios).
O padrão é autossômico dominante com expressão variável
- **Traumas e estresse repetitivo;**
- **Envelhecimento;**
- **Obesidade:** pela sobrecarga nas articulações levando a degeneração;
Obesidade é um fator positivo para OA de joelhos e quadril (não tão clara)
- **Instabilidade articular;**
- **Alterações na bioquímica e morfologia da cartilagem:** como Gota, hemofilia;
- **Neuropatias.**

Podem ser secundárias a:

- Artrite Reumatóide;
- Gota e Pseudogota;
- Hemofilia;
- Hemocromatose;
- Necrose asséptica;
- Artrite;
- Meniscectomia ou dano meniscal;
- Doença de Paget: distúrbio crônico do esqueleto em que a renovação óssea é acelerada.

Fisiopatologia

O condrócito detecta dano ao tecido com ação do óxido nítrico, IL-1 β e TNF- α . Com essas alterações, os condrócitos liberam proteinases, catepsinas e metaloproteinases que degradam a matriz cartilaginosa, levando ao rompimento precoce da armação da matriz molecular ($\downarrow$ proteoglicanos e $\uparrow$ conteúdo aquoso), com formação de fissuras superficiais e perda da resistência e elasticidade da cartilagem.

Inicialmente ocorre **fibrilação da superfície cartilaginosa e irregularidade das superfícies articulares**, com discreto estreitamento do espaço articular.

Com a progressão, os condrócitos liberam ainda mais enzimas proteolíticas e ocorre **afinamento progressivo da cartilagem**, com liberação de fragmentos para o espaço articular, podendo gerar resposta inflamatória leve (**sinovite**).

O osso subcondral desenvolve microfraturas, evoluindo para **esclerose subcondral** (aumento da densidade óssea). Há também **remodelação óssea**, com formação de **osteófitos** e **cistos subcondrais**.

Nas fases avançadas, ocorre **perda quase completa da cartilagem**, com exposição do osso subcondral (osso contra osso), estreitamento acentuado do espaço articular, fibrose capsular e morte dos condrócitos, perpetuando o ciclo degenerativo.

Quadro Clínico

Início insidioso, progressivo, ao longo de vários anos.

Acomete mais articulações de carga como coluna e mãos. O acometimento de ombros, cotovelos e punhos é pouco frequente.

A dor é inicialmente protocinética ("a medida que vou me esquentando a dor vai melhorando") desaparecendo ao repouso (mas se quadros muito graves, pode se manter ao repouso).

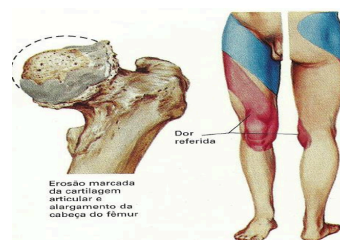
A dor é de caráter difusa, não localizada, diferindo de bursites, lesões ligamentares ou meniscais, tendinites.

A dor pode ser agravada pelas mudanças de tempo e por atividade crescente.

A rigidez é curta e dura 30 minutos. Pode haver crepitações e estalidos durante a movimentação, comumente referem dor a descer escadas em joelho e quadril.

▼ Osteoartrite de Coxo-femoral

Muito incapacitante. A dor localiza-se na região **inguinal ou nas nádegas**, podendo irradiar-se pela face medial das coxas até os joelhos, ou externamente pelo tensor da fáscia lata até o joelho.



É agravada com a marcha ou o movimento para sentar e levantar de superfícies baixas. Comumente vai para prótese mais precocemente do que os pacientes com osteoartrite de joelho.

▼ Osteoartrite de Joelhos

É a articulação mais acometida, e mais em **mulheres**.

A dor nos joelhos é ao levantar da cadeira, iniciar a deambulação, subir e descer escadas, com limitação a flexão e a extensão.

Joelhos em varo ou valgo podem estar presentes.

No RX notamos pinçamento articular e osteófitos, com redução do espaço articular.

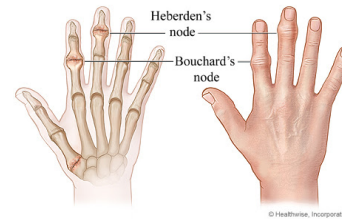
▼ Osteoartrite das Mãos

Referem perda da habilidade manual e da força de preensão, acometendo mais a articulação carpometacarpal e trapezioescafóide.

Interfalangeana proximas e interfalangeana distal com rigidez matinal de curta duração.

Nos casos de artrite erosiva, referem dor, aumento de calor e até hiperemia.

Pode ter os **nódulos de hederben (IFD) e Bouchard (IFP)** e a rizoartrose que acomete o polegar (artrose da base do polegar), essas alterações são bem comuns.



▼ Ombro

Articulação acromioclavicular é a mais acometida, em trabalhadores da construção civil, com mais de 50 anos.

▼ Pés

Ocorre mais na metarsofalangeana, ocorre em 44% após os 80anos. Especialmente em mulheres que usam sapatos apertados por tempo prolongado.

▼ Coluna vertebral

Acomete principalmente a coluna cervical e lombar.

Na coluna lombar pode haver estenose do canal medular, com claudicação de membros inferiores, aonde continua ao parar.

▼ Exame físico

Ao exame físico pode-se encontrar:

- Alargamento articular com dor a palpação;
- Limitação do movimento articular e instabilidade, edema;
- Episódios de bloqueio da articulação são devidos à presença de corpo livre no liquido sinovial.

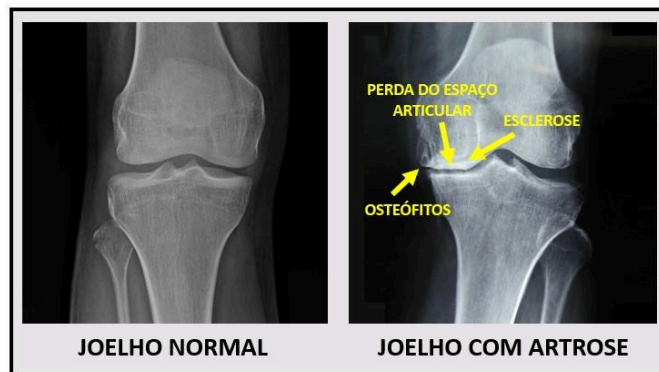
Quase a metade dos pacientes com OA de joelhos tem desvios articulares, mais sendo comum o varismo, por diminuição articular no compartimento medial.

Classificação

- Idiopática;
- Secundária;
- Localizada: restrita a um ou a dois grupos articulares como joelhos, quadris;
- Generalizada: envolve três ou mais grupos.

Exames complementares

- **Provas inflamatórias:** normais e inespecíficos. Lembrar que no idoso o VHS pode ser fisiologicamente levemente aumentado;
- **Rx Simples:** redução do espaço articular, esclerose subcondral e osteófitos. Pode haver cistos e erosões em alguns casos;



- **Tomografia ou RNM:** visualizar a coluna, ligamentos, lesões por outros fatores.

Tratamento

O tratamento clínico da OA objetiva aliviar os sintomas e manter o idoso o mais funcional possível, pois a doença leva a:

- Perda da qualidade de vida e das atividades básicas de vida diária (ABVDs) e atividades instrumentais de vida diária (AIVDs);
- Hipotrofia muscular: redução de massa muscular em quadríceps causa ainda mais dor pois força mais o joelho, por isso é indicado musculação ou pilates;
- Isolamento social;

- Depressão;
- Aceleração do processo de perda cognitiva;
- Aumento do risco de quedas e fraturas;
- Risco aumentado de mortalidade.

Obs: além disso pode mascarar outras doenças, por exemplo IC, como saber se o paciente tem dispneia ao caminhar 1 quadra se ele não caminha, caminha apenas em casa.

▼ **Medidas gerais:**

- Identificar fatores de risco;
- Perder peso;
- Calçados com amortecedores ou de borracha, com estabilidade do pé: especialmente em osteoartrite de calcâneo (esporão);
- Uso de bengala contralateral a lesão: cabo da bengala deve ficar até altura do fêmur, com o cotovelo levemente flexionado;
- Uso de joelheiras de neoprene fenestradas para realinhamento da patela, joelheiras com tensor: estabilidade ao joelho.

Fisioterapia é muito importante para fortalecimento muscular, melhorar amplitude de movimento e a marcha. Exercício tai chi chuan é uma modalidade oriental com movimentos lentos que auxiliam na amplitude articular e equilíbrio.

Hidroginástica e Órteses de posicionamento (especialmente noturna para auxiliar com a dor, principalmente em casos de rizoartrose) também podem ser indicadas.

▼ **Medidas farmacológicas**

Devemos analisar a intensidade da dor do paciente.

- Dipirona e acetamenofem como tratamento adjuvante;
- AINH: preferencialmente os COX-2 (menos problemas gástricos) ou não COX-2 com inibidor de bomba, em caso de pouca resposta ao acetaminofem;

São nocivos ao paciente idoso então devemos utilizar pelo menor tempo possível, no máximo 7-10 dias.

- Hidroxicloroquina e cloroquina: mais utilizada em osteoartrite de mãos, com eficácia razoável, pode causar hiperpigmentação da retina;
- AINEs tópicos e capsaicina: em OA de mãos;
- Opiáceos: em casos mais leves como tramadol, tramadol + acetaminofem, e casos mais graves como oxicodona, morfina, metadona. Mas podem causar constipação, sonolência, confusão mental;
- Duloxetina: em casos de dor crônica, nos casos sensibilização central, especialmente em OA de joelho e coluna;
- Gabapentina e pregabalina.

▼ Drogas de ação lenta

Tem falha na evidência e não está sendo mais utilizado na prática, como:

- Diacereína;
- Sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina;
- Extratos não saponificados de soja e abacate;
- Colágeno não hidrolisado e hidrolisado.

Dos que tem um pouco mais de comprovação científica, são:

- Cúrcuma longa: tem como efeito inibir a lipoxigenase/COX 2.
Destacam-se dois ensaios clínicos de excelente qualidade recentes sugerindo sua eficácia para a OAJ;

Usamos 500 mg 2x/dia e demora para fazer efeito, cerca de 4 semanas.

- Boswellia serrata: sua ação promove inibição da lipoxigenase.

▼ Terapias intra-articulares

- Corticoides: casos mais graves;
- Plasma rico em plaquetas: com potencial benefício em OAJ, mas inconclusivo;

- Ácido Hialurônico: aplicações geralmente nos joelhos (melhor), quadris e ombros e eventualmente em outras articulações.

▼ Cirurgia

Quando o paciente não melhora com o tratamento clínico, presença de deformidades como joelhos em varo ou valgo.

É realizado artroplastia total com colocação de prótese, na coluna é feito liberação do espaço intervertebral.

Idade avançada e obesidade não são contra indicações para a cirurgia. Devemos nos atentar mais a comorbidades e não apenas a idade do paciente.